Le traumatisme du poignet

Fracture de l’extrémité inférieure du radius et fracture du scaphoïde : le cours reconstruit à partir des QCM, pour comprendre et répondre.

Comment lire ce cours

TOMBE EN QCM signale un point déjà posé en QCM ; ×N = nombre de fois où il apparaît dans la banque (doublons entre sessions inclus, ordre de grandeur). Priorité : ★★★ ≥ 10 questions, ★★ 5 à 9, ★ moins de 5. ✔ = proposition juste · ✘ = proposition fausse (les pièges). Les encadrés rouges signalent les contradictions entre la banque, le cours et le corrigé officiel.

À propos du contenu

- Le cours (service d’orthopédie, CHU Mostaganem) traite deux sujets : la **fracture de l’extrémité inférieure du radius (EIR)** et la **fracture du scaphoïde**. Le PDF suit ce plan, puis ajoute ce que la banque teste autour (canal carpien, algodystrophie, nerf radial, Monteggia/Galeazzi).
- Banque exploitée : environ **108 QCM** rangés dans le chapitre « Traumatismes du poignet » (dont une dizaine de cas cliniques mal classés : ostéoporose, accident de travail, morphine…) et une soixantaine d’autres répartis dans les chapitres voisins. Je n’ai gardé que ce qui sert au poignet.
- Le recueil corrigé fournit, pour chaque question, la justification « selon le cours » ; je m’en sers pour trancher quand la clé officielle est douteuse.

Les 10 points à connaître avant tout

1. La fracture de l’EIR est **la plus fréquente de l’appareil locomoteur** ; terrain = **femme âgée ostéoporotique** (> 50 ans), mécanisme **indirect**.
2. **Pouteau-Colles** = chute sur la paume, **hyperextension** → trait **sus-articulaire (extra-articulaire)**, déplacement **postérieur**, **dos de fourchette**. 85–90 % des fractures de l’EIR.
3. Déplacement : **bascule postérieure + translation externe + ascension** du fragment distal (ligne bistyloïdienne horizontalisée, main botte radiale, baïonnette).
4. **Goyrand-Smith** = hyperflexion, déplacement **antérieur**, **ventre de fourchette** : instable → **toujours chirurgical** (plaque vissée antérieure). Idem fractures marginales antérieures.
5. Traitement du Pouteau-Colles : **orthopédique possible** (réduction + BABP), chirurgical (brochage, Kapandji) si déplacement important ou instabilité. Jamais « toujours chirurgical ».
6. Complications de l’EIR : **cal vicieux** (la plus citée), **algodystrophie**, raideur, déplacement secondaire, canal carpien. **Pseudarthrose et ostéonécrose : exceptionnelles**.
7. **Scaphoïde** = fracture la **plus fréquente du carpe** (75 %), sujet jeune, mécanisme **indirect**. Signe : douleur de la **tabatière anatomique**.
8. Radio initiale normale **n’élimine pas** la fracture : incidence de Schneck, revoir à 10–15 jours, scanner / IRM ; en cas de doute, immobiliser.
9. Vascularisation **unique, rétrograde** (entre par le tiers distal) → fractures **proximales** : **ostéonécrose** du pôle proximal et pseudarthrose. Chirurgie (vis de Herbert) si proximale/déplacée.
10. Ne pas confondre : **Monteggia** = ulna + tête radiale ; **Galeazzi** = radius + radio-ulnaire distale ; **Barton** = marginale (articulaire).

Ce qui tombe le plus

Thème	Fréquence	Priorité
Fracture de Pouteau-Colles (mécanisme, trait, déplacement, déformation, traitement)	≈ 34	★★★
Fracture du scaphoïde (clinique, radio, nécrose, traitement)	≈ 16	★★★
Complications de l’EIR (cal vicieux, algodystrophie, canal carpien)	≈ 12	★★★

Thème	Fréquence	Priorité
Traitement de l'EIR (orthopédique / chirurgical, déplacement antérieur)	≈ 11	★★★
Généralités de l'EIR (fréquence, terrain, mécanisme, radio-ulnaire)	≈ 10	★★★
Nerf radial (paralysie) — posé dans ce chapitre	≈ 10	★★★
Syndrome du canal carpien post-traumatique	≈ 8	★★
Algodystrophie du poignet	≈ 8	★★
Monteggia / Galeazzi / avant-bras	≈ 6	★★
Radiographie normale du poignet, critères de réduction	≈ 4	★
Autres : Barton, Gérard-Marchant, kyste synovial, synostose, ligne de Wagner	≈ 1–3 chacun	★

1 · La fracture de l'extrémité inférieure du radius TOMBE EN QCM ×10 ★★★

Définition : ensemble des fractures épiphysaires et métaphysaires de l'extrémité inférieure du radius, situées **jusqu'à 4–5 cm au-dessus de l'interligne radio-carpien**.

Intérêt	À retenir
Fréquence	**1re place en traumatologie d'urgence** : fracture la plus fréquente de l'appareil locomoteur
Terrain	**Sujet âgé > 50 ans, femme ménopausée** (ostéoporose = facteur favorisant), en nette augmentation ; chez l'adulte jeune lors d'un accident violent (AC, AVP, AT)
Mécanisme	**Indirect** le plus souvent (chute sur la main) ; direct exceptionnel
Diagnostic	Clinique, complété par la radio (face + profil)
Pronostic / gravité	Dépend de la qualité du traitement ; risque de séquelles fonctionnelles et morphologiques

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×10 **Généralités de l'EIR**

- ✔ **La plus fréquente de l'appareil locomoteur**
- ✔ Peut perturber les rapports de l'articulation radio-cubitale (la face interne forme la cavité sigmoïde)
- ✔ Survient le plus souvent par mécanisme **indirect**
- ✔ Le facteur favorisant est l'**ostéoporose** ; plus fréquente chez la **femme âgée après une chute de sa hauteur**
- ✔ La réduction est une **urgence fonctionnelle** (ni vitale, ni esthétique)
- ✔ Chez la femme âgée, la forme la plus fréquente est la fracture **comminutive** (refends articulaires) plutôt que le Pouteau-Colles pur
- ✘ Surtout chez le sujet jeune après traumatisme violent
- ✘ La moins fréquente / 2e place après le fémur
- ✘ Mécanisme le plus souvent direct
- ✘ Prédominance masculine
- ✘ Traitement toujours chirurgical · ne se déplace jamais sous traitement orthopédique

Piège fréquent : les énoncés inversent « la plus fréquente » en « la plus rare ». Pouteau-Colles = la plus fréquente des EIR, pas la plus rare.

2 · Anatomie et physiologie utiles TOMBE EN QCM ×4 ★

Repère	Valeur normale
Glène radiale, plan sagittal	Regarde en bas et **en avant**, inclinaison sagittale (bascule) de **≈ 10°**
Plan frontal	Inclinaison en haut et **en dedans de 20–25°** (ligne bistyloïdienne à 10° de l'horizontale)
Index radio-ulnaire inférieur	Tête cubitale **≈ 2 mm plus haut** que la glène : index le plus souvent **négatif** (épaisseur du ligament triangulaire)
Mobilité	Flexion palmaire 85° (radio-carpienne 50°, médio-carpienne 30°) ; extension 85° (30° / 50°) ; inclinaison radiale 25° (15° / 10°)
Pronosupination (Destot)	Exige : courbures du **radius**, intégrité de la **radio-ulnaire inférieure**, intégrité de la **membrane interosseuse**

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×4 **Radio normale et critères de réduction**

- ✔ Aspect normal : index radio-ulnaire le plus souvent **négatif** · inclinaison **palmaire** de la glène · capitatum, lunatum et radius **alignés** sur le profil
- ✔ Bonne réduction : glène regardant **en bas et en dedans** de face
- ✔ Pronosupination : respect des courbures du radius, intégrité de la RUI et de la membrane interosseuse
- ✘ Diastasis radio-ulnaire distal · inclinaison frontale de 5°
- ✘ Courbures du cubitus ou intégrité de la radio-carpienne comme conditions de la pronosupination

Le profil montre le déplacement antérieur ou postérieur ; la fracture se voit de face + profil.

PIÈGES

Glène sur le profil. Une question de la banque marque « en bas et **en arrière** sur le profil » comme critère de bonne réduction, alors que le cours donne une glène normalement orientée **en avant de 10°** (inclinaison palmaire, confirmée par une autre question). Si vous voyez ces deux propositions, la clé de la banque est « en arrière ✔ / en avant ✘ » ; retenez la valeur anatomique du cours pour le reste.

3 · Mécanisme et classification de Castaing TOMBE EN QCM ×6 ★★

La classification de **Castaing** est la plus utilisée : elle sépare deux grandes familles selon le mécanisme.

	Compression-extension	Compression-flexion
Fréquence	**85–90 %** des fractures de l'EIR	10–15 % (6,5–10 % selon la diapositive détaillée)
Chute sur	**Paume** de la main, poignet en hyperextension	**Dos** de la main, poignet en hyperflexion
Déplacement	**Postérieur**	**Antérieur**
Fracture type	**Pouteau-Colles** (sus-articulaire)	**Goyrand-Smith** (sus-articulaire)
Déformation	**Dos de fourchette**	**Ventre de fourchette**
Fractures articulaires	3e fragment postéro-interne (Castaing), T sagittal, T frontal, croix, éclatement, composante externe ou interne, marginale postéro-externe (**Rhea-Barton**), styloïde radiale (cunéenne externe)	Marginales antérieures : type I simple (rebord antérieur), type II complexe (+ séparation métaphyso-épiphysaire, luxation antérieure du massif carpien)
Traitement	Orthopédique ou chirurgical selon le déplacement	**Toujours chirurgical** : instable, plaque vissée antérieure

4 · La fracture de Pouteau-Colles TOMBE EN QCM ×34 ★★★

Le thème n°1 de la banque : la même question revient sous quinze formulations. Retenir la fiche d'identité ci-dessous résout presque tous les items.

Critère	Pouteau-Colles
Mécanisme	Chute sur la **paume**, poignet en **hyperextension** (indirect). Pas en hyperflexion, pas en pronation forcée, pas de coup direct
Trait	**Sus-articulaire (extra-articulaire)**, à 15–25 mm au-dessus de l'interligne radio-carpien

Critère	Pouteau-Colles
Déplacement du fragment distal	**Bascule postérieure** + **translation externe** (+ ascension / engrènement) = déformation « en baïonnette » de face, en **dos de fourchette** de profil
Signes cliniques	Dos de fourchette ; **main botte radiale** (inclinaison radiale) ; ascension de la styloïde radiale, **horizontalisation** de la ligne bistyloïdienne ; saillie de la styloïde cubitale ; dépression sus-articulaire dorsale (comminution postérieure) ; douleur métaphysaire ; quelques mouvements possibles ; ouverture cutanée rare
Terrain	**Femme âgée ostéoporotique** ; apanage du sujet âgé
Traitement	**Peut être orthopédique** (réduction + BABP) ; chirurgical (brochage) si déplacement important ou instabilité
Variante	**Gérard-Marchant** = Pouteau-Colles + fracture de la styloïde cubitale

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×34 **Pouteau-Colles : propositions justes**

- ✔ Fracture à **trait sus-articulaire** (extra-articulaire)
- ✔ Déplacement **postérieur** ; bascule postérieure + **translation externe** du fragment distal
- ✔ Mécanisme : **hyperextension**, chute sur la paume
- ✔ Déformation en **dos de fourchette**
- ✔ Le traitement **peut être orthopédique**
- ✔ Apanage du sujet âgé ; fréquente chez la femme ostéoporotique
- ✔ Ascension de la styloïde radiale ; saillie interne de la styloïde cubitale ; **horizontalisation** de la ligne bistyloïdienne ; main botte radiale
- ✔ Cas clinique : suspecté sur l'**âge**, la **chute sur la paume**, le **sexe féminin**, l'**inclinaison en valgus** du poignet ; signes : tuméfaction, douleur métaphysaire, dépression sus-articulaire dorsale, quelques mouvements possibles
- ✔ Radio : bascule postérieure + translation externe du fragment distal ; comminution **postérieure** ; la styloïde cubitale associée = Gérard-Marchant
- ✔ Traitement chirurgical primaire : **embrochage**, indiqué selon l'importance du déplacement et l'instabilité
- ✘ Fracture articulaire / intra-articulaire
- ✘ Déplacement **antérieur** ; bascule antérieure ; déplacement antérieur de la glène
- ✘ Hyperflexion
- ✘ Déformation en **ventre de fourchette**
- ✘ Traitement toujours chirurgical
- ✘ Ouverture cutanée fréquente · pseudarthrose fréquente
- ✘ Fracture la **plus rare** des fractures de l'EIR
- ✘ Verticalisation de la ligne bistyloïdienne
- ✘ Paresthésies du médian comme signe caractéristique (c'est une complication)

Quand l'énoncé demande les réponses fausses, les bonnes cases sont : fracture articulaire · chute en hyperflexion · ventre de fourchette · traitement toujours chirurgical.

PIÈGES

Pouteau-Colles « articulaire ». Une question de la banque coche « fracture intra-articulaire » et « hyperflexion » comme justes : c'est une erreur de clé (l'énoncé était un « réponses fausses »). Le corrigé officiel de la session retient D et E seulement : dos de fourchette et traitement orthopédique possible. Dans le doute, **extra-articulaire, hyperextension, déplacement postérieur**.

Déplacement « antérieur de la glène » ou « translation interne ». Toujours faux pour le Pouteau-Colles : c'est postérieur et externe.

Mécanisme d'un cas clinique. Une question (femme de 74 ans) marque « compression » et « hyperflexion » comme mécanismes et non l'hyperextension. Cela contredit le cours ; ne pas l'adopter.

5 · Goyrand-Smith et fractures à déplacement antérieur TOMBE EN QCM ×8 ★★

- **Goyrand-Smith** : fracture sus-articulaire par compression-flexion (chute sur le dos de la main, poignet fléchi), déplacement **antérieur** en **ventre de fourchette**, ascension de la styloïde radiale, translation externe de l'épiphyse. Pose un problème de réduction.
- **Fractures marginales antérieures** (articulaires) : type I (détachement du rebord antérieur) et type II (séparation métaphyso-épiphysaire avec luxation antérieure du massif carpien). **Toutes les fractures à déplacement antérieur sont instables** et leur traitement est **chirurgical**.

- **Barton** = fracture marginale articulaire (la marginale postéro-externe est dite de **Rhea-Barton**). **Smith** = déplacement antérieur et flexion.

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×8 **Déplacement antérieur**

- ✔ Traitement d'une EIR à déplacement antérieur ou d'une marginale antérieure : **réduction sanglante + plaque vissée par voie antérieure**
- ✔ Smith : déplacement **antérieur** et en flexion
- ✔ Barton : fracture **intra-articulaire**
- ✔ Le profil radiographique montre le déplacement **antérieur**
- ✔ Une chute en avant sur la main donne le plus souvent des fractures à **bascule postérieure** (grande majorité des EIR)
- ✔ Goyrand-Smith : fracture **extra-articulaire** (non articulaire)
- ✘ Traitement orthopédique · plâtre simple
- ✘ Brochage type Py / Kapandji · embrochage classique
- ✘ Plaque par voie postérieure
- ✘ Fixateur externe (réservé aux fractures ouvertes selon le corrigé)
- ✘ Goyrand-Smith comme fracture articulaire (la banque la donne extra-articulaire)

Retenir : déplacement antérieur → plaque vissée antérieure, jamais de brochage ni de plâtre seul.

6 · Complications de l'EIR TOMBE EN QCM ×12 ★★★

Délai	Complications (cours)
Immédiates	Ouverture cutanée ; **syndrome du canal carpien** (conflit contenant-contenu, irritation du médian : douleurs nocturnes accentuées par l'hyperextension, l'hyperflexion et la percussion)
Secondaires	Œdème sous plâtre ; sepsis sur broche ; **déplacement secondaire** ; **syndrome neuro-algo-dystrophique**
Tardives	Nerveuses : névrome irritatif du nerf radial, compression du médian, compression du cubital (rare, canal de Guyon). Rupture tendineuse (**long extenseur du pouce**, origine ischémique). Troubles de la radio-ulnaire inférieure. **Cals vicieux** (fréquents, même après ostéosynthèse ; correction si mal tolérés). Séquelles : **raideur** du poignet, **arthrose** radio-carpienne

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×12 **Complications**

- ✔ **Cal vicieux** · **algodystrophie** · **raideur du poignet** · déplacement secondaire (sous plâtre)
- ✔ Les **deux plus fréquentes chez la femme âgée** (compression-extension) : **algodystrophie** et **cal vicieux**
- ✔ Après un Pouteau-Colles immobilisé 45 jours : **syndrome du canal carpien** et **algodystrophie**
- ✔ Paresthésies nocturnes des 3 doigts externes + amyotrophie thénar, 6 mois après un Pouteau-Colles = **canal carpien** (et non Guyon, Volkmann ou algodystrophie)
- ✔ Cas du Goyrand-Smith plâtré : douleurs et dysesthésies des doigts, plus marquées la nuit, extension des doigts conservée = **canal carpien**
- ✔ L'algodystrophie survient après un traumatisme même minime, fréquente chez les sujets anxieux et après Pouteau-Colles
- ✘ Pseudarthrose (exceptionnelle) · ossification péri-articulaire · nécrose post-traumatique
- ✘ Ostéonécrose
- ✘ « Jamais de déplacement secondaire »
- ✘ Compression du médian comme complication **la plus fréquente** / ouverture des téguments
- ✘ Syndrome de Volkmann · névralgie cervico-brachiale

Algodystrophie à 8 semaines : peau luisante, amplitudes diminuées, douleurs inflammatoires (2e moitié de nuit, dérouillage > 30 min). Radio normale possible, hypertransparence sous-chondrale, hypersignal T2 en IRM, hyperfixation scintigraphique précoce (pas d'hypofixation, pas de VS augmentée).

PIÈGES

Algodystrophie non retenue par une clé. Une session a omis cette lettre alors que le cours la place parmi les complications (« syndrome algodystrophique ++ »). La bonne réponse reste : cal vicieux, algodystrophie, raideur.

Canal carpien post-traumatique. Dans le cas de la patiente de 36 ans, la banque ne demande aucun examen complémentaire. Traitement médical : arrêt de travail court, attelle de fonction, infiltration de corticoïde au pli du poignet (pas d'infiltrations mensuelles). Chirurgie : section du ligament annulaire du carpe, endoscopique ou à ciel ouvert, d'emblée en cas de déficit moteur ; pas de neurolyse systématique.

7 · Traitement de l'EIR TOMBE EN QCM ×11 ★★★

Buts : réduction la plus anatomique possible, stabilité, restauration de la fonction, éviter les séquelles.
Urgence fonctionnelle.

Méthode	Détail (cours)	Quand ?
Orthopédique	Réduction (traction douce progressive sous anesthésie) + immobilisation plâtrée **BABP** (brachio-antébrachio-palmaire) ; plâtre simple si fracture non ou peu déplacée	Pouteau-Colles peu déplacée / stable ; retrait de l'immobilisation vers **6 semaines**, kinésithérapie sans attendre
Ostéosynthèse à foyer fermé	Réduction + **brochage** percutané classique ; brochage **intra-focal de Kapandji** (1973) ; brochage iso-élastique (Py, 1969) ; fixateur externe	Déplacement postérieur important ou instable
Ostéosynthèse à foyer ouvert	**Plaque vissée antérieure**	**Déplacement antérieur**, marginales antérieures, fractures articulaires complexes

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×11 **Traitement et conduite à tenir**

- ✔ Fractures peu déplacées de l'extrémité distale du radius : **immobilisation plâtrée**
- ✔ Chirurgie indiquée en cas de **déplacement important**
- ✔ Réduction orthopédique : **avant la 6e heure**, par **traction douce sur le pouce**, sous anesthésie (pas sans aucune anesthésie), réduction de la corticale antérieure d'abord
- ✔ Femme de 74 ans (EIR déplacée) : ostéosynthèse par embrochage percutané et immobilisation par manchette ; retrait de l'immobilisation vers 6 semaines, **kinésithérapie sans attendre**
- ✔ Radios de première intention : **poignet de face** et **profil strict** (pas d'incidence du canal carpien, pas de clichés fonctionnels)
- ✘ Réduction par pression manuelle antéro-postérieure ou contention en extension (reproduit la bascule postérieure)
- ✘ Chirurgie dans tous les cas · ostéotomie radiale systématique · cerclage · fixateur externe
- ✘ Radiographies hebdomadaires jusqu'à la 6e semaine · retrait systématique du matériel

PIÈGES

Plâtre BABP. Le cours le cite comme moyen orthopédique ; la banque le coche faux dans un cas d'EIR déplacée chez une patiente de 36 ans (ostéosynthèse à foyer ouvert ✔, « la méthode d'immobilisation n'est pas consensuelle » ✔). Selon l'énoncé : peu déplacé → plâtre ; déplacé → chirurgie.

Fixateur externe. Cité dans les moyens par le cours (foyer fermé) ; le corrigé le réserve aux fractures ouvertes et la banque le coche faux pour une fracture fermée. **Brochage vs plaque :** brochage et Kapandji = déplacement postérieur ; plaque vissée = déplacement antérieur.

8 · La fracture du scaphoïde carpien TOMBE EN QCM ×16 ★★★

Fracture la plus fréquente du carpe (≈ 75 %), du sujet jeune. Le piège est le **diagnostic manqué** (examen clinique et radiologique insuffisants) qui conduit au stade de **pseudarthrose**. Adage de Watson-Jones : devant tout traumatisme fermé du poignet sans déformation évidente, on présume une fracture du scaphoïde jusqu'à preuve du contraire.

8.1 Anatomie, vascularisation, mécanisme

- 80 % de la surface est **cartilage** (5 surfaces articulaires), **pas de périoste** : la consolidation se fait par un **cal endostal** → réduction parfaite impérative.
- **Vascularisation** par l'artère radiale : apport **palmaire** 20–30 % (pôle distal) et **dorsal** 70–80 % (entre par l'isthme), **sans anastomose** entre les deux réseaux. Tout le sang entre par le **tiers inférieur** : le pôle supérieur est presque obligatoirement dévascularisé en cas de fracture du tiers supérieur = **artère unique rétrograde**.
- **Mécanisme :** indirect, **hyperextension** (95 %), bord radial du poignet. Fractures du tiers moyen les plus fréquentes (Weber-Chao ; Mayfield).
- **Classification de Schernberg :** I polaires supérieures, II corporéales hautes, III corporéales basses, **IV trans-tubérositaires**, V fractures du pied, VI fractures du tubercule distal. Les fractures distales sont extra-articulaires, donc moins graves.
- Lésions associées : EIR, styloïde radiale ou ulnaire, os pyramidal et grand os, ligament scapho-lunaire interosseux, polytraumatisme.

8.2 Diagnostic

	Contenu
Clinique	Douleur du bord externe du poignet, provoquée à la **palpation de la tabatière anatomique** (poignet en adduction), appui sur le **tubercule du scaphoïde**, mobilité diminuée ; impotence fonctionnelle **relative** ; pas de déformation
Pièges	Ne pas faire de radios · se contenter de face + profil · manquer une fracture du radius associée ou une luxation du carpe
Radiologie	**4 incidences** classiques : main à plat, poignet fermé, position de **Schneck**, profil. Le trait peut être invisible au début : refaire à **10–15 jours**, ou **scanner / IRM**
Conduite	Au moindre doute : radiographie. Fracture → traitement ; **pas de fracture mais doute → immobilisation 10 jours** puis réévaluation (scanner / IRM)

8.3 Traitement et complications

- **Orthopédique** : **gant plâtré** (+ BABP) pour les fractures non déplacées ; le gant doit **prendre la colonne du pouce** (ne pas libérer la MCP du pouce).
- **Chirurgical** : **vissage de Herbert** ; indiqué pour les fractures déplacées, comminutives ou **proximales**.
- **Complications : pseudarthrose** (la plus fréquente), **ostéonécrose du fragment proximal**, cal vicieux, arthrose du poignet, complications iatrogènes. Les fractures articulaires retentissent sur la mécanique du carpe et s'associent souvent à des lésions ligamentaires.

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×16 **Scaphoïde**

- ✔ **La plus fréquente** des fractures des os du carpe · parfois découverte au **stade de pseudarthrose**
- ✔ Signes : douleur à la palpation de la **tabatière anatomique**, impotence relative, **radio de face et profil normale**
- ✔ Mécanisme indirect ; **fractures proximales → ostéonécrose** ; vascularisation à **artère unique rétrograde** (vascularisation proximale précaire)
- ✔ L'examen radiologique est souvent plus démonstratif au **10e–15e jour** ; un scanner peut l'explorer
- ✔ Certaines fractures non déplacées : manchette type scaphoïde
- ✔ Schernberg type IV = fracture **trans-tubérositaire**
- ✔ Fractures proximales : **chirurgicales** ; évolution défavorable vers l'**arthrose** du poignet ; complication la plus fréquente = **pseudarthrose** (les 2 principales : pseudarthrose et ostéonécrose du fragment proximal)
- ✔ Ne se complique pas habituellement de nécrose : la fracture **sous-trochantérienne** du fémur (col de l'humérus, scaphoïde, col fémoral, col de l'astragale se compliquent de nécrose)
- ✘ Fracture la plus rare du carpe · diagnostic toujours facile · traitement toujours chirurgical · traumatisme direct
- ✘ **Une radiographie normale élimine la fracture** (faux : le piège du cours)
- ✘ « Tableau de main clouée » · rupture fréquente de l'artère radiale dans la tabatière
- ✘ Elle entraîne rarement une nécrose · consolide en moyenne en 3 mois (marqué faux)
- ✘ Douleur à la flexion-extension du pouce · déformation en ventre de fourchette
- ✘ Gant plâtré libérant la MCP du pouce
- ✘ Nécrose du fragment proximal : complication la plus fréquente de la fracture de type IV (faux) · ostéonécrose du fragment distal
- ✘ Scaphoïde fréquent chez le sujet âgé (c'est une fracture du sujet jeune)

Bilan de la patiente de 36 ans : une douleur de la tabatière fait suspecter le scaphoïde, un scanner peut l'explorer, et la fracture modifie la prise en charge. Pseudarthrose aseptique du poignet = non-consolidation après 3 mois (banque).

9 · Ce que la banque teste autour du poignet TOMBE EN QCM ×12 ★★★

9.1 Nerf radial (paralysie)

Atteinte	Signes
Motrice	**Main tombante** : impossibilité d'étendre le **poignet**, les **doigts** (MCP) et le **pouce** ; déficit d'abduction du pouce ; main en pronation. La flexion palmaire du poignet et l'adduction du pouce sont **conservées**
Sensitive	Anesthésie du **bord radial du dos de la main** / face dorsale de la 1re commissure et du pouce ; si atteinte haute : face postérieure de l'avant-bras
Contexte	Fracture de la diaphyse humérale (on teste les extenseurs du poignet et des doigts) ; au pli du coude : mêmes signes ; atteinte haute : réflexe tricipital diminué

ATTENTION

Abduction du pouce. Quatre questions marquent le déficit d'abduction du pouce comme juste dans la paralysie radiale, une seule le marque faux. Retenir : déficit juste. Main en griffe et signe de Froment = nerf **ulnaire** ; main de prédicateur et déficit de flexion = nerf médian.

9.2 Monteggia, Galeazzi et autres

Lésion	Définition	À retenir
Monteggia	Fracture de l'**ulna** (diaphyse) + luxation de la **tête radiale**	Chute sur le bras en pronation forcée ; l'ostéosynthèse de l'**ulna** réduit la tête radiale ; devant une fracture isolée de l'ulna, chercher la luxation
Galeazzi	Fracture de la diaphyse du **radius** + luxation de la **radio-ulnaire distale**	Instabilité de la RUD ; pas de luxation de la tête radiale
Avant-bras (2 os)	Fractures diaphysaires des deux os	Complication la plus fréquente : **raideur de la pronosupination** ; plaque vissée chez l'adulte ; radiographie coude et poignet inclus
Synostose radio-ulnaire congénitale	Fusion au coude, limitation de la **pronosupination**	Ostéotomie de réorientation-rotation devant une pronation exagérée

9.3 Divers

- **Kyste synovial** : tumeur des tissus mous du poignet la plus fréquente ; face dorsale, mou et fluctuant, peut régresser spontanément ; la ponction n'est pas le traitement de référence et la récidive après exérèse n'est pas rare.
- Le mécanisme du « **tableau de bord** » donne fracture de la rotule, fracture-luxation postérieure de la hanche et lésions ligamentaires du genou, **pas** de fracture du poignet. La classification de Lauge-Hansen concerne la **cheville**.
- Fracture comminutive du **trapèze** : retentit sur la stabilité du 2e métacarpien, l'ouverture de la 1re commissure et la pince pouce-index. Ligne de Wagner : ligne de dislocation autour du semi-lunaire (clé de la banque).
- Fractures du poignet et ostéoporose : un homme sous traitement hormonal pour cancer de prostate qui se fracture les deux poignets présente une ostéoporose secondaire (hypogonadisme), pas des métastases.

10 · Fiche flash : vrai ou faux ?

Affirmation	Réponse
La fracture de l'EIR est la plus fréquente de l'appareil locomoteur.	VRAI
Elle survient surtout chez le sujet jeune par traumatisme direct.	FAUX
Le Pouteau-Colles est une fracture articulaire.	FAUX (sus-articulaire)
Le Pouteau-Colles est dû à une chute en hyperflexion.	FAUX (hyperextension)
Il donne une déformation en dos de fourchette, avec bascule postérieure et translation externe.	VRAI
Le ventre de fourchette est celui du Goyrand-Smith.	VRAI
Le Pouteau-Colles peut être traité orthopédiquement.	VRAI
Une EIR à déplacement antérieur se traite par plaque vissée antérieure.	VRAI
La pseudarthrose est une complication fréquente de l'EIR.	FAUX (exceptionnelle)
Le cal vicieux et l'algodystrophie sont les complications les plus fréquentes.	VRAI
Paresthésies nocturnes des 3 doigts externes après Pouteau-Colles : canal carpien.	VRAI
Le scaphoïde est la fracture la plus rare du carpe.	FAUX (la plus fréquente)
Une radiographie normale élimine une fracture du scaphoïde.	FAUX
La douleur de la tabatière anatomique évoque le scaphoïde.	VRAI
La vascularisation du scaphoïde est à artère unique rétrograde.	VRAI
Les fractures proximales du scaphoïde évoluent volontiers vers l'ostéonécrose.	VRAI
Le traitement du scaphoïde est toujours chirurgical.	FAUX
Monteggia : fracture de l'ulna et luxation de la tête radiale.	VRAI
Galeazzi : fracture du radius et luxation de la radio-ulnaire distale.	VRAI
La paralysie radiale donne une main tombante.	VRAI